

AN czuje się *jak rozwiązanie*

W depresji, lęku, OCD — pacjent chce się pozbyć objawów. W AN objawy czują się jak tożsamość, wartość, kontrola. To różnica zasadnicza dla leczenia.

CZAS: 20–25 min psychoedukacji **REALIZACJA:** wczesne sesje, integracja z MI / MANTRA

ŹRÓDŁO: Vitousek, Watson & Wilson (1998); Schmidt & Treasure (2006, *pro-ana beliefs*); Treasure & Schmidt (2013, MANTRA — cognitive-interpersonal maintenance model)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **różnica ego-syntoniczne kontra ego-dystoniczne**. W sekcji 02 — **sześć funkcji**, jakie AN pełni dla pacjenta (Schmidt & Treasure). Sekcja 03 — **twoja praca**: identyfikacja funkcji + bilans korzyści i kosztów. Sekcja 04 — dlaczego walidacja funkcji nie jest „popieraniem AN”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ego-syntoniczność to rdzeniowa cecha AN różniująca ją od depresji czy lęku. Pacjent *nie* czuje AN jako „choroby” — czuje ją jako „*siłę woli*”, „*tożsamość*”, „*kontrolę*”. Vitousek i in. (1998): perswazja („*spójrz, AN Cię niszczy*”) *wzmacnia* opór (zjawisko *reactance*, Brehm, 1966). Skuteczne podejście — MI Miller & Rollnick (2013): *wywoływanie* argumentów od pacjenta, nie ich narzucanie. Komunikat: „*AN coś Ci daje. Sprawdźmy razem, czy warto tej ceny*”.

01

Ego-syntoniczne kontra ego-dystoniczne — rdzeniowa różnica

EGO-DYSTONICZNE (WIĘKSZOŚĆ ZABURZEŃ)

Depresja, lęk, OCD. Pacjent *cierpi* przez objawy, *chce* się ich pozbyć, motywacja do leczenia jest naturalna. Klasyczne CBT może pracować bezpośrednio z myślami i zachowaniami.

EGO-SYNTONICZNE (AN)

Objawy czują się jak tożsamość. Restrykcja, niska waga, kontrola — dają poczucie wartości, bezpieczeństwa, sukcesu. Pacjent jest *chwiejny* w motywacji: jednocześnie *chce* i *nie chce* wyzdrowieć. CBT bez wcześniejszej pracy z motywacją nie działa.

02 Sześć funkcji AN (Schmidt & Treasure)

FUNKCJA	CO AN „ROZWIĄDUJE”
1 · Kontrola	„Jedna rzecz, którą kontroluję”. W świecie chaosu — pozorna przewidywalność. Wszystko inne może się walić, ale waga jest „moja”.
2 · Tożsamość	„Jestem osobą z AN” — stabilna definicja siebie. Bez AN: „kim jestem? Nie wiem”.
3 · Bezpieczeństwo	Restrykcja jako „zbroja” przed światem. „Jeśli będę mała/-y, nikt mnie nie skrzywdzi”, „nie zauważą”.
4 · Poczucie sukcesu	Kontrola wagi jako <i>mierza</i> lnie osiągnięcie. W obszarze, gdzie inne sukcesy są niedostępne lub niewystarczające — AN „daje wyniki”.
5 · Regulacja emocji	Głodzenie <i>tłumi</i> emocje (mechanizm somatyczny). „Gdy nie jem, nie czuję”. Zamiast pracy z emocjami — somatyczne wyciszenie.
6 · „Specjalność”	Bycie chudym jako wyróżnienie, „inność” interpretowana jako wartość. „Jeśli przestanę, będę zwykły/-a”.

03 Identyfikacja funkcji + bilans (do pracy z terapeutą)

KTÓRE FUNKCJE ROZPOZNAJĘ U SIEBIE NAJMOCNIEJ

— może być kilka; bez ocen, bez wstydu; to nie jest „popieranie AN”

CO AN „ROZWIĄDUJE” W MOIM ŻYCIU

— konkretne sytuacje, emocje, doświadczenia; jak AN „pomaga”

CO AN MNIE KOSZTUJE

— zdrowie, relacje, plany, energia, koncentracja, radość, sen;
bez bilansowania — tylko obserwacja

INNE SPOSOBY NA ZASPOKOJENIE TYCH POTRZEB

— co innego daje kontrolę / sukces / tożsamość / regulację
emocji; do pracy z terapeutą

Klucz: ego-syntoniczność AN *nie* jest „brakiem motywacji” — jest *biologią i psychologią* tego konkretnego zaburzenia. AN *coś rozwiązuje* dla pacjenta: daje kontrolę w chaosie, tożsamość w pustce, sukces w obszarze, gdzie inne sukcesy są niedostępne. Klinicysta, który tego nie rozumie, sfrustrowany „brakiem motywacji”, żąda zmiany, której pacjent biologicznie i psychologicznie nie może jeszcze zechcieć. **Walidacja funkcji** jest *pierwszym krokiem* — uznanie, że AN nie jest „bezsensowna”, że pacjent *nie jest* głupi ani uparty. Bez walidacji pacjent nie zaufa terapii. Po walidacji dopiero możliwe jest: „co AN kosztuje?” i „jakie są inne sposoby?”. Treasure i Schmidt (2013, MANTRA): cognitive-interpersonal maintenance model — ego-syntoniczność jest jednym z czterech mechanizmów podtrzymujących AN, obok perfekcjonizmu i sztywności poznawczej, lęku i unikania emocji oraz reakcji bliskich. Praca z każdym z nich jest częścią leczenia.

△ Walidacja funkcji nie jest popieraniem AN. Jest uznaniem, że dla pacjenta AN *coś rozwiązuje* — i że to „coś” wymaga innego rozwiązania, nie wymagań abstynencji. To różnica między: „musisz przestać głodzić się” (frustracja, opór) a „rozumiem, że AN daje ci kontrolę. Co innego mogłoby dawać ci kontrolę, bez tych kosztów?” (przymierze terapeutyczne, otwartość). MI (Motivational Interviewing) i MANTRA są tu kluczowymi modalnościami.